



FACULDADE
CIÊNCIAS MÉDICAS
UMA INSTITUIÇÃO FELUMA



Cortical × subcortical · confrontos · árvore

Saúde do Idoso

Diagnóstico diferencial das demências

Como decidir qual demência é — confronto a confronto

TEMA	Diferencial das demências: raciocínio comparativo e árvore de decisão
AUTOR	Prof. Dr. Igor Moraes — CRM-MG 76695 (RQE Geriatria 66254; Clínica Médica; Cardiologia)
DISCIPLINA	Saúde do Idoso — 9º período
INSTITUIÇÃO	FCMMG — Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais
CARGA HORÁRIA	35 minutos (panorâmica)
DATA / VERSÃO	2026 · v1.0

Dois idosos, “mesma” queixa de memória — mas NÃO são a mesma doença



Foto ilustrativa · CC BY-SA

Sr. A., 72

Esquece fatos recentes; some palavras; se perde em lugares conhecidos.

→ Cortical?



Sra. B., 72

Lenta, “preguiçosa”, desatenta; esquece mas LEMBRA com pistas; anda devagar.

→ Subcortical?

Ao final, você decide qual demência é — com método



Estruturar

1

o 1º corte: padrão cortical × subcortical.



Separar

2

demência de mimetizadores (normal, delirium, depressão).



Confrontar

3

os pares difíceis (AD×vascular, AD×DCL, DFT×psiquiátrico).



Reconhecer

4

demências rápidas (DCJ) e red flags de urgência.



Usar

5

imagem/biomarcadores para dirimir e mudar a conduta.

Alinhamento construtivo: cada objetivo é cobrado por ≥1 questão no quiz.

Como pensar → mimetizadores → confrontos → rápidas → imagem → árvore



Foco em DECISÃO, não em descrição: cada parada te dá uma regra prática.

O subtipo muda tratamento, prognóstico e segurança



Tratamento difere

anticolinesterásico (AD/DCL) × controle vascular × derivação (HPN)



Segurança

neuroléptico pode ser perigoso no DCL; anticoagulação na vascular



Prognóstico/curso

rápido (DCJ) × degraus (vascular) × lento (AD)



Aconselhamento

familiar/genético (FTD precoce); planejamento de cuidado

“Tudo é Alzheimer” é o erro que custa caro — o rótulo errado leva à conduta errada.

Primeiro decida: o padrão é CORTICAL ou SUBCORTICAL?



CORTICAL

- Amnésia (esquece e NÃO recupera com pistas)
- Afasia, apraxia, agnosia (os “4 A”)
- Ex.: Alzheimer, frontotemporal
- Marcha normal no início



SUBCORTICAL

- Lentificação + déficit executivo + desatenção
- Memória melhora COM pistas (recuperação)
- Humor/movimento: apatia, parkinsonismo
- Ex.: vascular, Parkinson/DCL, HPN

Teste prático: dê pistas na evocação. Recuperou → subcortical/recuperação. Não recuperou → cortical/consolidação (Alzheimer).

Não confunda demência com seus 3 grandes imitadores



Envelhecimento normal

- Esquecimentos leves, sem perda funcional
- Queixa sem declínio objetivo
- Não progride para incapacidade



Delirium

- Início AGUDO, atenção flutuante
- Causa orgânica; reversível
- Sempre excluir primeiro



Depressão

- Pseudodemência: melhora c/ pistas
- Humor rebaixado, “não tento”
- Tratável → cognição melhora

Regra: exclua delirium e depressão (e reveja fármacos) ANTES de classificar a demência.

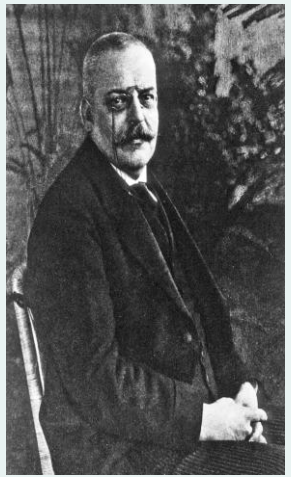
Quadro-resumo: a 1ª queixa aponta o caminho

Subtipo	Padrão	1ª queixa	Marca registrada
Alzheimer	Cortical	Memória episódica	Amnésia sem recuperação
Vascular	Subcortical	Executivo/lentidão	Degraus + fatores/lacunas
Frontotemporal	Cortical (frontal)	Conduta ou linguagem	Jovem; desinibição/apatia
Corpos de Lewy	Mista/subcortical	Flutuação + alucinação	Parkinsonismo; REM; ↑neurolépt.
HPN	Subcortical	Marcha + urina	Tríade + ventrículos↑ (DESH)

Use como “mapa de bolso” — os confrontos a seguir aprofundam os pares que mais confundem.

Alzheimer × Demência vascular

Alzheimer



A. Alzheimer · PD

- Cortical: amnésia que NÃO melhora com pistas
- Início insidioso, declínio LENTO e contínuo
- RM: atrofia hipocampal/temporal medial
- Marcha preservada no início

Vascular



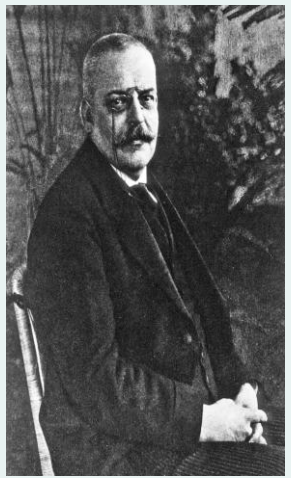
O. Binswanger · PD

- Subcortical: executivo/lentidão; memória c/ pistas
- Curso em DEGRAUS ou pós-AVC; flutua
- RM: lacunas, leucoaraiose, infartos
- Fatores vasculares; marcha/sinais focais precoces

Como decidir: curso (degraus×lento) + memória (com×sem pistas) + RM (vascular×hipocampo). No idoso, frequentemente MISTA.

Alzheimer × Corpus de Lewy

Alzheimer



A. Alzheimer · PD

- Memória episódica domina desde o início
- Cognição estável ao longo do dia
- Alucinações tardias (fase avançada)
- Sem parkinsonismo precoce

Corpos de Lewy



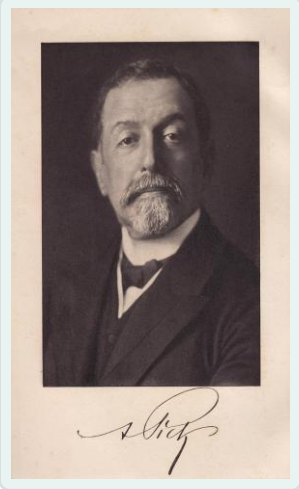
F. H. Lewy · PD

- FLUTUAÇÃO cognitiva marcante (dia a dia)
- Alucinações visuais PRECOCES e bem formadas
- Parkinsonismo; quedas; disautonomia
- Transtorno do sono REM; ↑sensib. a neurolépticos

Como decidir: flutuação + alucinação visual precoce + parkinsonismo + REM = Lewy. Atenção: NÃO dar neuroléptico típico.

Frontotemporal × Transtorno psiquiátrico (e × Alzheimer)

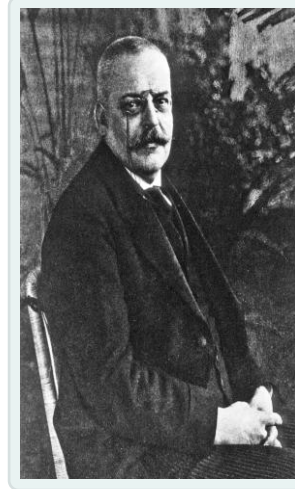
Frontotemporal (bvFTD)



A. Pick · PD

- MUDANÇA de personalidade/conducta; desinibição/apatia
- Início < 65 anos; perda de empatia, hiperoralidade
- Memória relativamente poupada no início
- RM: atrofia frontal/temporal anterior

Psiquiátrico / Alzheimer



comparação · PD

- Depressão/bipolar: humor é o eixo; responde a tto
- Sem atrofia frontal focal; curso conforme humor
- Alzheimer: memória domina (≠ conducta)
- Histórico psiquiátrico prévio favorece psiquiátrico

Como decidir: mudança de PERSONALIDADE/conducta em <65 com memória poupada e atrofia frontal = pense FTD, não “depressão”.

Vascular × Mista — e os parkinsonismos lado a lado

Vascular “pura” × Mista

- Pura: relação temporal com AVC/lacunas; predomínio executivo
- Mista: amnésia (Alzheimer) + carga vascular — muito comum no idoso
- Decisão: avalie o PESO de cada componente e trate os dois

Parkinsonismo + demência

- DCL: demência ANTES/junto do parkinsonismo (regra do 1 ano)
- Parkinson-demência (PDD): parkinsonismo ANTES (anos)
- Atípicos (PSP/AMS/DCB): quedas precoces, olhar vertical, rigidez axial



Como decidir nos parkinsonismos: a ORDEM e o TEMPO dos sintomas (cognição × movimento) e os sinais atípicos (quedas precoces, paralisia do olhar) separam DCL, PDD e parkinsonismos atípicos. Atípico → encaminhar.

CASO · PONTO DE DECISÃO

Idoso com flutuação, “vê pessoas” e ficou rígido. Qual hipótese — e o que EVITAR?

Pistas

- Cognição flutua muito no mesmo dia
- Alucinações visuais bem formadas
- Parkinsonismo recente; quedas
- Esposa: “fala/“luta” dormindo” (REM)

Hipótese e conduta

A

Alzheimer; iniciar haloperidol p/ alucinação

B

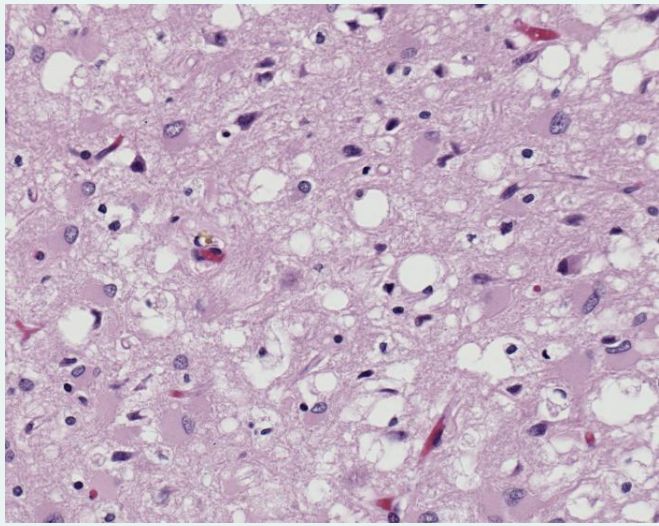
Corpos de Lewy; EVITAR neuroléptico típico, tratar com cautela

C

Transtorno psicótico primário; antipsicótico em dose alta

Resposta: B — quadro de DCL; neuroléptico típico pode causar reação grave.

Demência rapidamente progressiva: pense em DCJ (e em causas tratáveis)



Degeneração espongiforme (DCJ) · PD/CC



Quando suspeitar

declínio em semanas–meses (não anos); mioclonias; ataxia



DCJ — apoio diagnóstico

RM (DWI): restrição cortical/“ribboning” e núcleos da base; RT-QulC no LCR; EEG (complexos periódicos)



Não esquecer o tratável

autoimune/paraneoplásica, tireoide (Hashimoto), B12, infecções, tóxico-metabólico

RED FLAGS QUE DESVIAM A ROTA

Sinais que dizem “não é demência degenerativa típica — investigue”



Evolução rápida

semanas–meses



Início precoce

< 65 anos



Mioclonias/convulsões

prônica, autoimune



Marcha/quedas precoces

HPN, atípicos, DCL



Sinais focais

vascular, tumor, HSD



Flutuação/consciência

delirium, DCL



Sintomas sistêmicos

autoimune, infeccioso

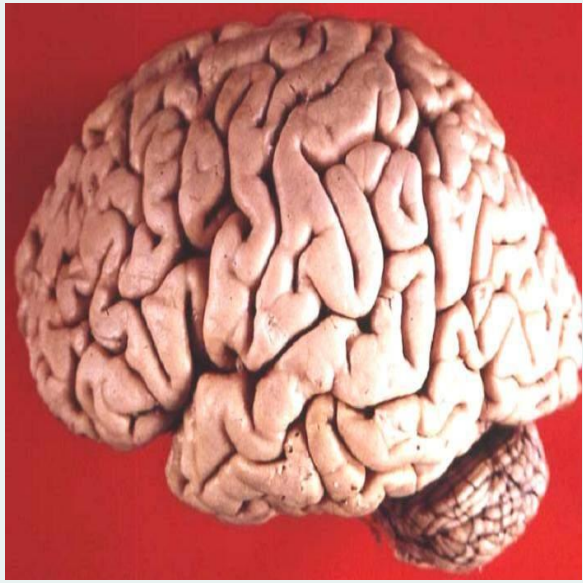


História familiar forte

genético (FTD/AD precoce)

Qualquer red flag → ampliar investigação e/ou encaminhar ao especialista.

Padrões de neuroimagem que ajudam a fechar o diferencial



Encéfalo · J.A. Beal · CC BY 2.5



Atrofia hipocampal/temporal medial

→ **Alzheimer**



Lacunas, leucoaraiose, infartos

→ **Vascular / mista**



Atrofia frontal/temporal anterior

→ **Frontotemporal**



Restrição cortical em DWI

→ **DCJ (priônica)**



Ventrículos↑ desproporcionais / DESH

→ **HPN (tratável!)**

A imagem confirma a hipótese clínica — e flagra o que é cirúrgico/tratável (HPN, HSD, tumor).

Quando o exame molecular/funcional ajuda a decidir



LCR / PET (ATN)

A β 42, p-tau; PET amiloide/tau → confirma Alzheimer em casos incertos



DAT-SPECT

Transportador de dopamina ↓ → apoia DCL/parkinsonismo (vs. AD)



RT-QuIC (LCR)

Alta especificidade para doença priônica (DCJ)



Autoimune/paraneo

Anticorpos no soro/LCR → encefalite tratável

Não são rastreio: peça quando o resultado MUDA a conduta ou o diagnóstico é incerto/atípico.

Uma árvore para decidir à beira-leito



Em qualquer ramo: a neuroimagem confirma e a clínica (curso + 1ª queixa) lidera.

Declínio em 3 meses, com mioclonias e ataxia. Próximo passo?

Pistas

- Evolução em SEMANAS–MESES (rápida)
- Mioclonias e ataxia
- Sem fatores vasculares; idade 68
- Piora visível a cada semana

Conduta

A

Rotular Alzheimer e observar por 1 ano

B

Demência rápida: RM (DWI) + LCR (RT-QuIC) + investigar autoimune/reversível

C

Iniciar anticolinesterásico e alta

Resposta: B — demência rapidamente progressiva exige investigação urgente (DCJ ≠ tratável).

Acertar o subtipo é acertar o cuidado



Alzheimer / DCL

anticolinesterásico (e memantina); no DCL pode ajudar alucinação



Vascular

controlar HAS/DM/FA/dislipidemia; antiagregação conforme caso



HPN

derivação (DVP) após tap test — potencialmente reversível



DCL — segurança

EVITAR neurolépticos típicos; cautela com atípicos



FTD

manejo comportamental, segurança, suporte ao cuidador; genética

E sempre: integrar à AGA (funcionalidade, humor, fármacos, rede) e comunicar com a família.

O erro nº 1: pular o padrão e ir direto ao rótulo



A armadilha

Ver “idoso esquecido” e cravar Alzheimer

→ perde DCL (neuroléptico perigoso), HPN (operável), rápida (urgente), depressão (tratável).



Como evitar

- Padrão primeiro (cortical×subcortical), rótulo depois
- Velocidade do curso + 1ª queixa + imagem
- Procure ativamente DCL, HPN e o reversível



Curiosidade: os nomes do diferencial são pessoas reais — Alzheimer, Pick, Lewy, Binswanger, Creutzfeldt e Jakob, Hakim. Cada confronto carrega um século de observação clínica.

A régua do diferencial

1º CORTICAL ou SUBCORTICAL? → 2º a 1ª QUEIXA (curso) → 3º a IMAGEM confirma



Exclua imitadores

delirium, depressão e reversíveis (HPN!) vêm antes do rótulo.



Pares difíceis

AD×DCL (flutuação/alucinação/REM) ·
DFT×psiquiátrico (conduta<65) · vascular×mista.



Rápido muda a rota

semanas–meses → DCJ/autoimune: investigue já.
Atípico → encaminhe.

Teste rápido: Q1 a Q3

Q1

Esquece e LEMBRA com pistas, lento e desatento, anda devagar. Padrão?

A) Cortical B) Subcortical C) Delirium D) Normal

Q2

Flutuação + alucinações visuais + parkinsonismo + sono REM. Qual? E o que evitar?

A) AD B) DCL — evitar neuroléptico típico C) Vascular D) HPN

Q3

Mudança de personalidade/desinibição aos 60a, memória poupada. Diagnóstico?

A) Depressão B) Alzheimer C) Frontotemporal D) Delirium

Pense antes de virar o slide — gabarito comentado a seguir.

Mais três e os comentários

Q4. Declínio em 2 meses com mioclonias. Conduta?

Q5. Curso em degraus + lacunas na RM + HAS. Subtipo?

Q6. Idoso com declínio + marcha magnética + incontinência. Não perca?

Gabarito comentado

Q1 → B — Memória que melhora com pistas = subcortical (recuperação).

Q2 → B — DCL; neuroléptico típico pode causar reação grave.

Q3 → C — Conduta/desinibição em <65 com memória poupada = FTD.

Q4 → Rápida — DWI + RT-QulC; investigar DCJ e causas tratáveis já.

Q5 → Vascular — Degraus + lacunas + fatores de risco.

Q6 → HPN — Tríade de Hakim; reversível com derivação.

Recapitule agora — e revise nos próximos dias

Em 30 segundos, recupere de memória:

- A régua: padrão → 1ª queixa → imagem
- 3 sinais que separam AD de DCL
- O que torna uma demência “rápida”
- Os reversíveis a não perder (HPN!)



3 perguntas para revisar em D+2 e D+7

1. Como o teste de pistas separa cortical de subcortical?
2. Quais achados apontam DCJ?
3. Que confronto mais muda a conduta — e por quê?

REFERÊNCIAS (VANCOUVER)

Referências

1. American Psychiatric Association. DSM-5 — Transtornos Neurocognitivos. 2013.
2. Academia Brasileira de Neurologia (Neurologia Cognitiva e do Envelhecimento). Recomendações 2022 (Alzheimer; vascular; sindrômico). Dement Neuropsychol/Arq Neuropsiquiatr.
3. McKhann GM, et al. NIA-AA (Alzheimer). Alzheimers Dement. 2011. · Jack CR, et al. ATN. 2018.
4. Gorelick PB, et al. (AHA/ASA, vascular). Stroke. 2011. · VASCOG/NINDS-AIREN.
5. Rascovsky K, et al. bvFTD. Brain. 2011. · Gorno-Tempini ML, et al. APP. Neurology. 2011.
6. McKeith IG, et al. Consenso DLB (4ª ed.). Neurology. 2017. · Emre M, et al. PDD (MDS). 2007.
7. Hakim S, Adams RD. HPN. J Neurol Sci. 1965.
8. Zerr I, et al. Critérios diagnósticos de Creutzfeldt-Jakob (RT-QuIC/RM/EEG). Brain. 2009.
9. Folstein MF, et al. MMSE. 1975. · Brucki SMD, et al. MEEM no Brasil. Arq Neuropsiquiatr. 2003.
10. ELSI-Brasil — prevalência de demência. · Proporções de subtipos: literatura internacional.

Cortes/critérios variam por população; conferir validações e diretrizes vigentes.

CRÉDITOS

Créditos de imagens e nota de marca

Imagens documentais (domínio público / Wikimedia Commons):

- Alois Alzheimer, Arnold Pick, Otto Binswanger, Friedrich Lewy — domínio público
- Degeneração espongiforme (Creutzfeldt-Jakob) — domínio público / CC
- Encéfalo humano (J. A. Beal) — CC BY 2.5

Foto ilustrativa (Wikimedia, CC BY-SA): idoso no Brasil — Adam Jones. **Ícones:** Font Awesome. **Diagramas/árvore:** originais.



Marca institucional: logo oficial da CMMG / FELUMA na capa e banner no encerramento, de uso institucional. Paleta FCMMG.

Obrigado!

Qual demência é? **padrão** → **1ª** **queixa** → **imagem**.

Prof. Dr. Igor Moraes · CRM-MG 76695 (RQE Geriatria 66254) · Saúde do Idoso — FCMMG

